Pack stage IFSI (constantes, échelles, transmissions, précautions)

Repères de l'adulte pour le stage : constantes, échelles, transmissions, hygiène et AES

Clairance

Référentiel 2026 (arrêté du 20 février 2026, entrant.e.s à partir de septembre 2026) : gestes évalués en stage ou en pratique simulée dans l'UE B.3 « Pratiques et interventions infirmières » (S1, S2).
Repères de l'adulte. Les valeurs, seuils et conduites du protocole de votre service priment.

1 Constantes de l'adulte

Paramètre	Repère	Unité
Fréquence cardiaque (repos)	60 à 100	/min
Pression artérielle (consultation)	HTA si ≥ 140/90	mmHg
Pression artérielle (automesure)	HTA si ≥ 135/85	mmHg
Fréquence respiratoire (repos)	12 à 20	/min
SpO_2 (air ambiant)	≥ 95	%
Température	36,5 à 37,5	°C

NOTE CLINIQUE Valeur anormale ou inhabituelle
Recontrôler la mesure (matériel, position, repos), comparer aux valeurs précédentes du.de la patient.e et à l'état clinique, puis **alerter sans attendre** l'infirmier.e référent.e ou le.la médecin selon le protocole du service. Le recontrôle ne retarde jamais l'alerte devant un.e patient.e qui se dégrade.

PIÈGE
Un chiffre « normal » ne rassure pas seul : la tendance (valeurs successives) et l'aspect du.de la patient.e comptent autant. Une cible prescrite pour ce.tte patient.e (SpO_2 notamment) passe avant le repère du tableau.

2 Échelles de la douleur

Échelle	Cotation et seuil de prise en charge (indicateur HAS)
EVA	Auto-évaluation. Réglette de 0 à 10 cm (0 à 100 mm). Prise en charge si ≥ 4/10 (≥ 40/100).
EN	Auto-évaluation. Note de 0 à 10 donnée par le.la patient.e. Même seuil que l'EVA.
EVS	Auto-évaluation (échelle verbale simple). De 0 (absente) à 4 (extrêmement intense) : absente, faible, modérée, intense, extrêmement intense. Prise en charge si ≥ 2.
Algoplus	Hétéro-évaluation, personne âgée qui ne peut pas s'auto-évaluer. Score de 0 à 5. Prise en charge si ≥ 2.

Ces seuils sont ceux de l'indicateur de qualité : toute douleur exprimée se trace et se réévalue ; la conduite est celle du protocole du service.

PIÈGE
Choisir **une** échelle et la garder pour suivre l'évolution : un score d'EVA et un score d'EN ne se comparent pas d'une prise à l'autre. Tracer l'échelle utilisée avec le score.

3 Score de Glasgow

Item	Points	Meilleure réponse obtenue
Yeux (Y)	4	Ouverture spontanée
	3	À la demande ou au bruit
	2	À la douleur
	1	Aucune
Verbal (V)	5	Orientée
	4	Confuse
	3	Mots inappropriés
	2	Sons incompréhensibles
	1	Aucune
Moteur (M)	6	Obéit aux ordres
	5	Localise la douleur
	4	Évitement (retrait)
	3	Flexion stéréotypée (décortication)
	2	Extension stéréotypée (décérébration)
	1	Aucune

Score = Y + V + M, de 3 à 15. Noter le détail des trois items, pas seulement le total.

EXEMPLE Calcul du score
Yeux à la demande (3), réponse confuse (4), localise la douleur (5) : 3 + 4 + 5 = 12, à noter Y3 V4 M5.

NOTE CLINIQUE Baisse du score
Toute baisse par rapport à la cotation précédente s'alerte immédiatement, selon le protocole du service.

4 Risque d'escarre : échelle de Braden

Item	Cotation
Perception sensorielle	1 à 4
Humidité	1 à 4
Activité	1 à 4
Mobilité	1 à 4
Nutrition	1 à 4
Friction et cisaillement	1 à 3

Score total de 6 à 23 : **plus le score est bas, plus le risque est élevé.** Le seuil qui déclenche les mesures de prévention est celui du protocole du service.

5 Transmissions

Transmissions ciblées

- **Cible** : ce qui pose problème ou change (symptôme, réaction, événement), en quelques mots.
- **D, données** : faits observés et mesurés, propos du.de la patient.e.
- **A, actions** : ce qui a été fait, et par qui.
- **R, résultats** : effet observé, réévalué à l'heure dite.

SAED (adaptation française de SBAR, HAS)

- **S, situation** : qui j'appelle, pour quel.le patient.e, motif de l'appel, constantes.
- **A, antécédents** : contexte, traitements, allergies, évolution récente.
- **E, évaluation** : ce que j'en pense, ce qui m'inquiète.
- **D, demande** : ce que j'attends, dans quel délai ; puis reformuler la décision.

NOTE CLINIQUE Traçabilité
Écrire ce qui est fait, quand il est fait : date, heure, identification de l'auteur.rice. Chaque administration est tracée sur le même support que la prescription. Faits objectifs, sans jugement ; jamais d'acte tracé à l'avance.

6 Précautions standard

Champ (SF2H)
Pour tout soin, en tout lieu, pour tout.e patient.e, quel que soit son statut infectieux.

Les 5 indications de l'hygiène des mains (OMS)

1. Avant de toucher un.e patient.e.
2. Avant un geste aseptique.
3. Après un risque d'exposition à un liquide biologique.
4. Après avoir touché un.e patient.e.
5. Après avoir touché l'environnement du.de la patient.e.

Mesure	Repère
Mains	Friction hydro-alcoolique : technique de référence, gants ou non.
Gants	Si risque de contact avec du sang, un liquide biologique, une muqueuse ou une peau lésée ; pas de gants pour un contact avec une peau saine.
Masque, lunettes	Masque à usage médical (au minimum de type I, norme EN 14683) et lunettes si risque de projection ; masque pour le.la patient.e qui tousse.
Matériel	Matériel de sécurité et à usage unique ; conduite AES connue de tous.

7 Précautions complémentaires

Type	Mesures (en plus des précautions standard)
Air	Chambre individuelle, porte fermée. Appareil de protection respiratoire FFP2 mis **avant** d'entrer, même chambre vide ; étanchéité vérifiée (fit check) à chaque port. Masque chirurgical pour le.la patient.e qui sort de sa chambre.
Gouttelettes	Masque chirurgical pour le.la soignant.e dès l'entrée ; masque chirurgical pour le.la patient.e qui sort de sa chambre.
Contact	Hygiène des mains renforcée ; protection de la tenue (tablier) pour les soins au contact du.de la patient.e ou de son environnement.

PIÈGE
La signalétique sur la porte et le protocole du service indiquent le type de précautions : ne pas le déduire du diagnostic supposé.

8 Accident d'exposition au sang (AES)

Premiers soins, tout de suite (INRS)

Piqûre, coupure, peau lésée : ne pas faire saigner ; nettoyer à l'eau et au savon, rincer ; désinfecter au moins 5 min (Dakin, ou eau de Javel à 2,6 % de chlore actif diluée au 1/5e ; à défaut polyvidone iodée en solution dermique ou alcool à 70°).
Projection sur une muqueuse (œil, bouche, nez) : rincer abondamment au moins 5 min au sérum physiologique ou à l'eau.

NOTE CLINIQUE Délais
Dans l'heure : avis médical, selon la procédure AES de l'établissement, pour évaluer le risque infectieux ; un traitement post-exposition, s'il est indiqué, débute idéalement dans les 4 h. **Dans les 24 h :** informer sa hiérarchie (en stage : le service et l'IFSI), déclarer l'accident du travail, suivre les recommandations médicales, informer le.la médecin du travail.

PIÈGE
Ne pas attendre la fin du soin ou du poste pour consulter : le délai compte à partir de l'accident.

Sources : HAS (HTA de l'adulte, indicateur douleur IQSS, guide SAED), SF2H (précautions standard ; transmission par voie respiratoire), OMS (5 indications de l'hygiène des mains), INRS (affiche AES « En urgence : premiers soins à faire »), AP-HP (dossier de soins), CHUV (score de Glasgow), HUG (échelle de Braden), arrêtés relatifs au diplôme d'État d'infirmier ; détail dans les références du produit.